

Université MENTOURI 3

Faculté de médecine chalet des pins Constantine

Module de gastroentérologie

4 Emme année de médecine



CONDUITE A TENIR DEVANT UN ABDOMEN AIGU

Dr. MENOURA. R

**Maitre-assistant Hepato-biliopancreatique
Service de chirurgie digestive et endocrinienne**

E.H. DIDOUCHE MOURAD

CONSTANTINE 2025/2026

I. Définition

L'**abdomen aigu** est une **urgence médico-chirurgicale** caractérisée par une **douleur abdominale d'apparition brutale**, souvent associée à des **signes digestifs, généraux ou de choc**, nécessitant une **prise en charge rapide** pour identifier une cause **médicale ou chirurgicale**.

II. Objectifs de la prise en charge

1. **Confirmer la réalité de l'abdomen aigu** (urgence vraie).
2. **Identifier le mécanisme** : péritonéal, occlusif, hémorragique, ischémique, médical.
3. **Évaluer la gravité** : présence de choc, sepsis, défaillance viscérale.
4. **Orienter vers la chirurgie urgente** ou prise en charge médicale.

III. Démarche diagnostique

1 Interrogatoire (rapide mais précis)

- **Début et évolution** : brutal, progressif, intermittent.
- **Siège et irradiation** : épigastrique (pancréas), FID (appendicite), FIG (sigmoïdite), diffuse (péritonite).
- **Type de douleur** :
 - Crampiforme → occlusion.
 - Continue, intense → péritonite, perforation.
 - En colique biliaire, néphrétique → calcul.
- **Facteurs déclenchants ou calmants** : repas, vomissements, position.
- **Signes associés** : vomissements, arrêt des gaz, fièvre, diarrhée, métrorragies, aménorrhée (femme jeune).
- **ATCD** : chirurgicaux (adhérences ?), ulcère, lithiase, pathologie gynéco, cardiaque.

2 Examen clinique

a. État général

- Température, TA, FC, FR, SpO₂.
- **Recherche de choc** : TA basse, marbrures, agitation.
- **Déshydratation, ictère, pâleur.**

b. Inspection abdominale

- Distension, cicatrice, hernie, mouvements respiratoires abdominaux.

c. Palpation

- **Défense / contracture** → péritonite.
- **Masse palpable** → abcès, tumeur, volvulus, globe vésical.
- **Douleur localisée** :
 - FID → appendicite.
 - FIG → sigmoïdite.
 - Épigastre → ulcère perforé, pancréatite.

d. Percussion

- Matité déclive (ascite, épanchement).
- Tympanisme → occlusion gazeuse.

e. Auscultation

- Silence auscultatoire → iléus paralytique, péritonite.
- Bruits métalliques → occlusion mécanique.

f. Touchers pelviens

- TR : douleur cul-de-sac (péritonite, sigmoïdite), rectorragie.
- TV : douleur annexielle, masse pelvienne, cul-de-sac de Douglas douloureux.

3 Examens complémentaires (après stabilisation)

a. Bilan biologique urgent

Examen	Intérêt
NFS	Hyperleucocytose → infection / perforation
CRP	Inflammation
Iono / urée / créatinine	Retentissement rénal, déshydratation
Amylase / lipase	Pancréatite
Bilan hépatique	Ictère, cholestase
β-HCG	Exclure GEU
Lactates	Ischémie mésentérique

b. Imagerie

- **ASP (abdomen sans préparation)** : niveaux hydro-aériques (occlusion), pneumopéritoine.
- **Échographie abdominale** : première intention chez la femme, suspicion biliaire, pelvienne.
- **Scanner abdomino-pelvien injecté** : examen de référence, diagnostic étiologique et topographique.

IV. Classification des grands syndromes

L'analyse du **mécanisme physiopathologique** de la douleur abdominale aiguë permet d'orienter rapidement le diagnostic et la prise en charge.

On distingue cinq grands mécanismes : **péritonéal, occlusif, hémorragique, ischémique et médical.**

I. Syndrome péritonéal

1 Étiologies fréquentes

- Appendicite aiguë
- Ulcère gastrique ou duodéal perforé
- Péritonite biliaire (perforation vésiculaire)
- Perforation colique ou diverticulaire

2 Signes cliniques dominants

- **Douleur continue et intense**, souvent localisée puis rapidement diffuse.
- **Défense ou contracture abdominale** (ventre “de bois”).
- **Fièvre et syndrome infectieux**.
- **Arrêt du transit secondaire**.
- Respiration superficielle, **abdomen immobile à l’inspiration**.

3 Examens complémentaires

- **Scanner abdomino-pelvien injecté** : diagnostic étiologique et extension.
- **Biologie** : syndrome inflammatoire, hyperleucocytose.

4 Conduite à tenir

- **Urgence chirurgicale** : exploration, lavage, traitement de la cause.
- **Antibiothérapie probabiliste et réanimation préopératoire**.

II. Syndrome occlusif

1 Étiologies fréquentes

- Occlusion grêlique par **brides postopératoires**
- **Volvulus** (sigmoïde, grêle)
- **Hernie étranglée**
- **Cancer colique obstructif**

2 Signes dominants

- **Triade classique** : douleur abdominale + vomissements + **arrêt des gaz et des matières**.
- **Distension abdominale visible**.
- **Bruits métalliques** ou au contraire **silence auscultatoire** (iléus paralytique).
- Sensibilité diffuse sans défense.

3 Examens complémentaires

- **ASP** : niveaux hydro-aériques.
- **Scanner abdomino-pelvien** : confirme le diagnostic, précise **le siège et la cause de l’obstacle**.

4 Conduite à tenir

- **Réanimation initiale** (VVP, aspiration gastrique, correction hydro-électrolytique).
- Si **occlusion mécanique confirmée** → **chirurgie en urgence**.

III. Syndrome hémorragique intra-abdominal

1 Étiologies fréquentes

- **Grossesse extra-utérine rompue**
- **Rupture de rate** (traumatique ou spontanée)
- **Hémopéritoine post-traumatique ou iatrogène**
- **Ulcère gastroduodénal hémorragique**

2 Signes dominants

- **Douleur abdominale brutale et intense.**
- **Signes de choc hypovolémique** : TA basse, tachycardie, pâleur, sueurs froides.
- **Matité déclive** (liquide libre).
- Parfois **épaule douloureuse** (irritation phrénique).

3 Examens complémentaires

- **Échographie abdominale** : liquide libre.
- **Scanner abdominal injecté** : confirme la **source du saignement**.
- **Bilan biologique** : hémoglobine basse.

4 Conduite à tenir

- **Réanimation immédiate** (remplissage, transfusion).
- **Chirurgie ou embolisation urgente** selon l'étiologie.

IV. Syndrome ischémique

1 Étiologies fréquentes

- **Infarctus mésentérique** (thrombose ou embolie de l'artère mésentérique).
- **Volvulus intestinal avec strangulation.**
- **Torsion de bride** ou hernie étranglée.

2 Signes dominants

- **Douleur abdominale très intense**, souvent **disproportionnée par rapport à la pauvreté de l'examen.**
- Peu ou pas de défense initiale.
- Rapidement : **défaillance circulatoire, troubles métaboliques, acidose lactique.**

3 Examens complémentaires

- **Lactates plasmatiques élevés.**
- **Scanner abdomino-pelvien injecté** : absence de rehaussement intestinal, thrombose vasculaire.

4 Conduite à tenir

- **Urgence vitale** : réanimation + chirurgie exploratrice rapide.
- Si diagnostic précoce → possibilité de **thrombolyse ou d'angioplastie mésentérique.**

V. Abdomen aigu d'origine médicale (non chirurgical)

1 Étiologies fréquentes

- **Pancréatite aiguë**
- **Hépatite virale ou toxique**
- **Colique néphrétique**
- **Infarctus du myocarde inférieur**
- **Pneumonie basale droite**

2 Signes dominants

- **Douleur sans défense péritonéale.**
- Contexte clinique orientant :
 - **Éthylisme ou dyslipidémie** → pancréatite.
 - **Fièvre + toux** → pneumonie.

- Douleur lombaire irradiant vers les organes génitaux → colique néphrétique.
- ECG anormal → infarctus inférieur.

3 Examens complémentaires

- **Biologie adaptée** : lipase, transaminases, troponine, ECGU.
- **Imagerie ciblée** : échographie, scanner, ECG, radiographie pulmonaire.

4 Conduite à tenir

- **Traitement médical spécifique** de la cause.
- **Surveillance rapprochée.**
- **Aucune indication chirurgicale** sauf complication secondaire.

V. Conduite à tenir initiale

En parallèle du diagnostic : mesures de stabilisation

1. **Voie veineuse périphérique large** (2 si possible).
2. **Remplissage vasculaire** (cristalloïdes).
3. **Oxygénation, monitoring, scope, diurèse horaire.**
4. **Sondage gastrique** si vomissements/occlusion.
5. **Sondage urinaire** (diurèse, bilan entrée-sortie).
6. **Antalgie adaptée** (éviter morphiniques avant diagnostic certain si chirurgical).
7. **Antibiothérapie probabiliste** si sepsis ou péritonite.
8. **Jeûne strict.**
9. **Appel rapide du chirurgien.**

VI. Orientation étiologique rapide

Siège douleur	Diagnostic évoqué	Examen clé
FID	Appendicite, Crohn, GEU	Écho, scanner
FIG	Sigmoïdite, torsion sigmoïde	Scanner
Épigastre	Ulcère perforé, pancréatite, IDM inférieur	Scanner, ECG, lipase
Hypochondre droit	Colique hépatique, cholécystite	Échographie
Flanc	Colique néphrétique	Scanner sans injection
Diffuse	Péritonite, occlusion, ischémie	Scanner injecté

VII. Indications chirurgicales urgentes

- Péritonite généralisée (perforation d'organe creux).
- Occlusion intestinale mécanique.
- Appendicite aiguë compliquée.
- GEU rompue.
- Rupture de rate ou d'organe plein traumatique.
- Ischémie mésentérique confirmée.

VIII. Situations particulières

Femme en âge de procréer

→ Faire systématiquement un **test de grossesse (β-HCG)** pour éliminer une GEU.

Sujet âgé

→ Signes souvent **atténués** ; penser à diverticulite, ischémie mésentérique, occlusion sur cancer.

Enfant

→ Douleur souvent **mal localisée** ; penser à appendicite, invagination intestinale.

IX. Pièges diagnostiques à éviter

- **IDM inférieur** simulant une douleur épigastrique.
- **Pneumonie basale droite** simulant une cholécystite.
- **Cétonurie de déshydratation** simulant une pancréatite.
- **Colique néphrétique vs appendicite.**

Explications physiopathologiques

1.

- Les **vomissements prolongés** entraînent parfois une **cétonurie** avec **douleur épigastrique** et **lipase légèrement augmentée**, évoquant à tort une pancréatite.
- **Conduite à tenir :**
 - Rechercher un **contexte de jeûne ou de déshydratation**, corriger l'hydratation.

- Une **lipase** < **3N** et l'absence d'imagerie évocatrice écartent le diagnostic de pancréatite.

2.

- L'**IDM inférieur** peut se manifester par une **douleur épigastrique**, parfois isolée, **sans douleur thoracique typique**.
- La douleur est **profonde, mal localisée**, parfois accompagnée de **nausées ou vomissements**, ce qui peut faire évoquer une **pancréatite** ou un **ulcère perforé**.
- Conduite à tenir :
 - Toujours **réaliser un ECG et un dosage de troponine** devant une douleur épigastrique inexpliquée, surtout chez un patient âgé ou à risque cardiovasculaire.
 - Ne jamais conclure à un abdomen aigu chirurgical sans avoir **éliminé un IDM inférieur**.

DR raouf MENOURA